



TERAPIA FAMILIAR ESTRUTURAL

Profª. Mariana G. Boeckel

Minuchin, S.; Nichols, M. P. & Lee, W. Y. (2009). Famílias e casais: do sintoma ao sistema. Porto Alegre, Artmed.

Minuchin, S. & Fishman, C. (2004). Técnicas de terapia familiar. Barcelona: Paidós.

Nichols, M. & Schwartz, R. (1998). Terapia Familiar: conceitos e métodos. Porto Alegre: ArtMed.

TERAPIA FAMILIAR ESTRUTURAL

- 1921-2017
- 1970
- Principal Expoente: Salvador Minuchin
- Comportamento Familiar: estrutura que pode ser identificada pelos padrões consistentes, repetitivos, organizados e previsíveis.

A Estrutura facilita a intervenção do terapeuta

TERAPIA FAMILIAR ESTRUTURAL

Função da Terapia:

- Terapia destinava-se a descongelar a família de hábitos rígidos, criando a oportunidade para o surgimento de uma nova estrutura.
- Início com crianças institucionalizadas e sem situação de vulnerabilidade. Precisava de técnicas com ação. Terapeuta como participante ativo da família.

TERAPIA FAMILIAR ESTRUTURAL

- Trata-se de um plano para analisar o processo das interações familiares;
- Componentes essenciais:
 - ESTRUTURA;
 - SUBSISTEMAS;
 - FRONTEIRAS.

ESTRUTURA

- É o padrão organizado com que os membros da família interagem.
- Descreve as sequências que são previsíveis (repetições duradouras).
- Envolve um conjunto de regras que governam a família.

- Mudar alguma estrutura básica poderá provocar efeitos perturbadores nas transações da família;
- A estrutura é moldada por limitações universais e limitações idiossincráticas.
- EX: Todas famílias têm algum tipo de hierarquia, assim como os membros também têm funções recíprocas e complementares.

- Para reconhecer a estrutura familiar é necessário: sistema teórico que explique a estrutura e observar a família em ação.
- A estrutura só é evidente quando se observa as interações reais entre os membros da família no decorrer do tempo (sequências repetidas revelam padrões estruturais)

SUBSISTEMAS

- Cada indivíduo é um subsistema e díades ou grupos maiores compõem outros subsistemas determinados pela geração, gênero ou interesses comuns
- Todo membro da família desempenha muitos papéis em vários subgrupos (flexibilidade nos papéis)

FRONTEIRAS

- São barreiras invisíveis que envolvem os indivíduos e os subsistemas, regulando a quantidade de contato com os outros;
- Servem para proteger a autonomia da família e seus subsistemas, lidando com a proximidade e com a hierarquia.

- **Variam desde rígidas até difusas:**

Rígidas: distanciamento; desligamento

Nítida: limites normais

Difusa: emaranhamento ou fusão

CICLO VITAL

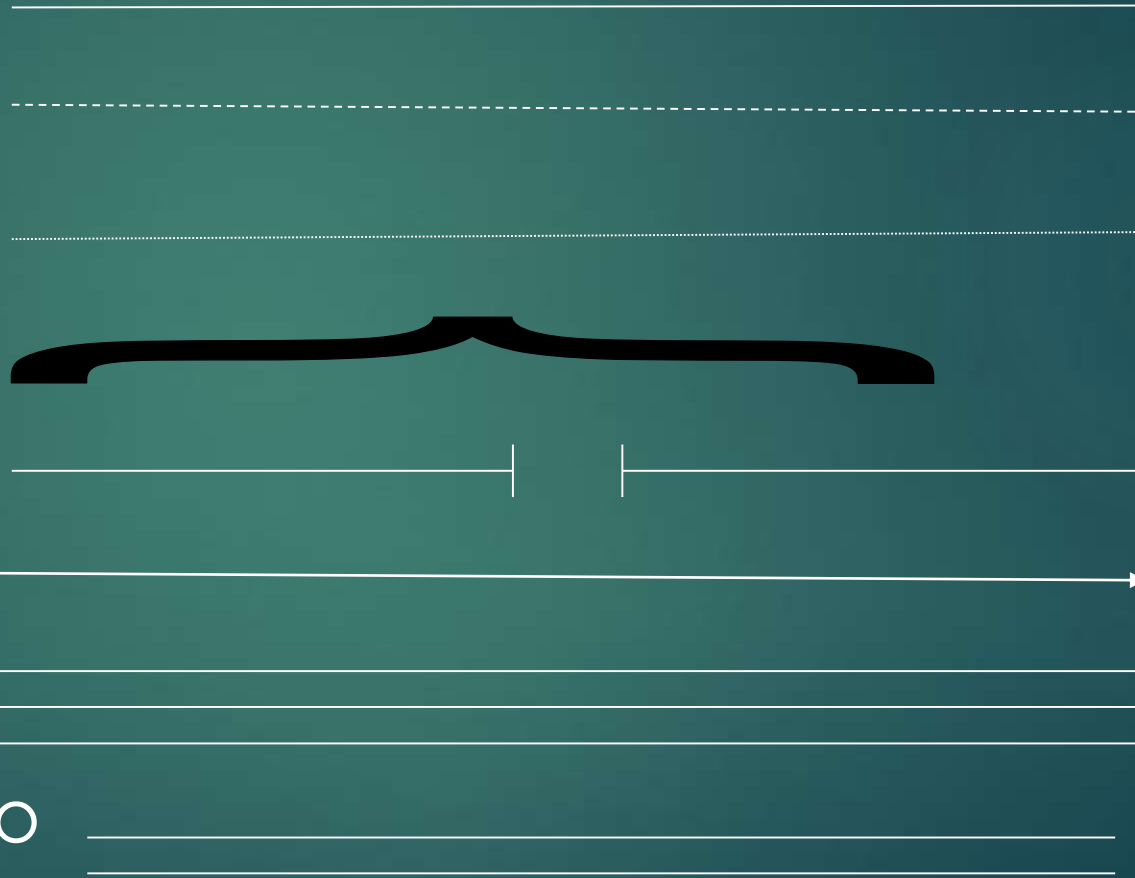
- Casal forma uma maneira de funcionar, com regras e acomodações até formar um padrão, uma estrutura;
- Complementaridade existem em todos casais e se tornam patológicos quando são exagerados-subsistema disfuncional;
- Terapia: desafiar os padrões estruturais que estão prejudicando o crescer da família.

Diagnóstico familiar

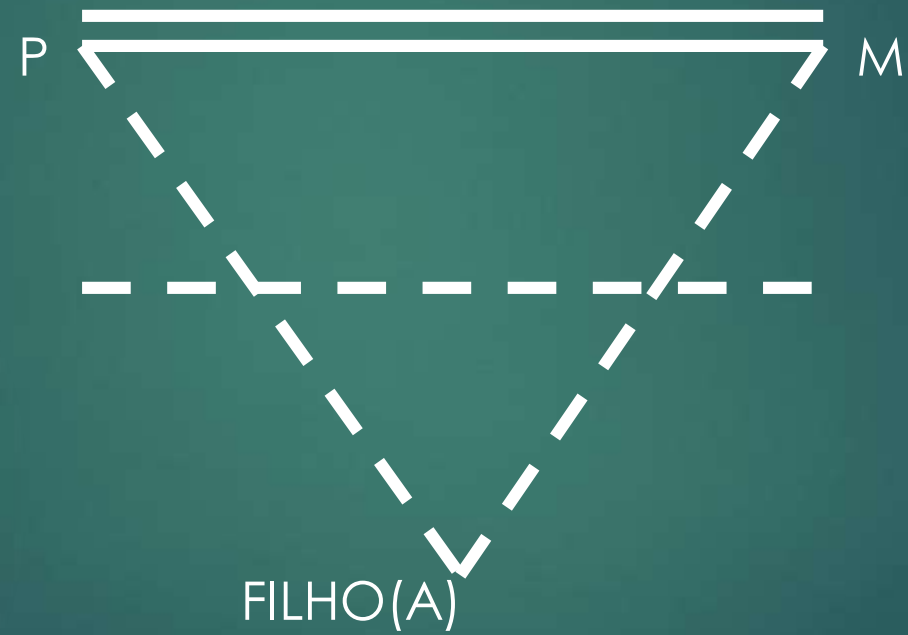
- Gráfico que auxilia na compreensão/ diagnóstico da família
- O gráfico é estanque e a família está em constante modificação
- Crítica ao modelo “socialmente esperado” de normalidade
- Atenção à “evitação do conflito”
 - Emaranhamento – negação de diferenças
 - Rigidez – ampliação do distanciamento

Gráficos

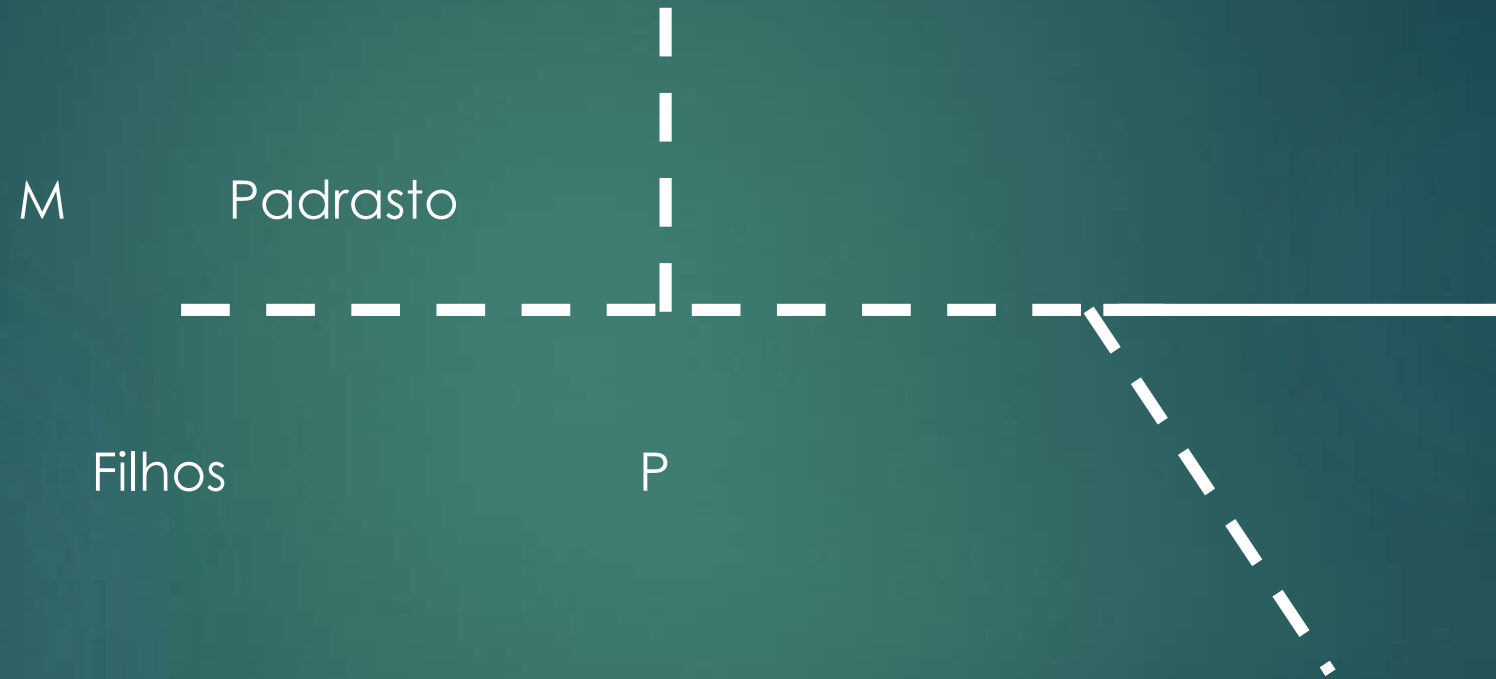
- Fronteira rígida
- Fronteira nítida
- Fronteira difusa
- Coalizão
- Conflito
- Desvio
- Emaranhamento
- Afiliação/associação



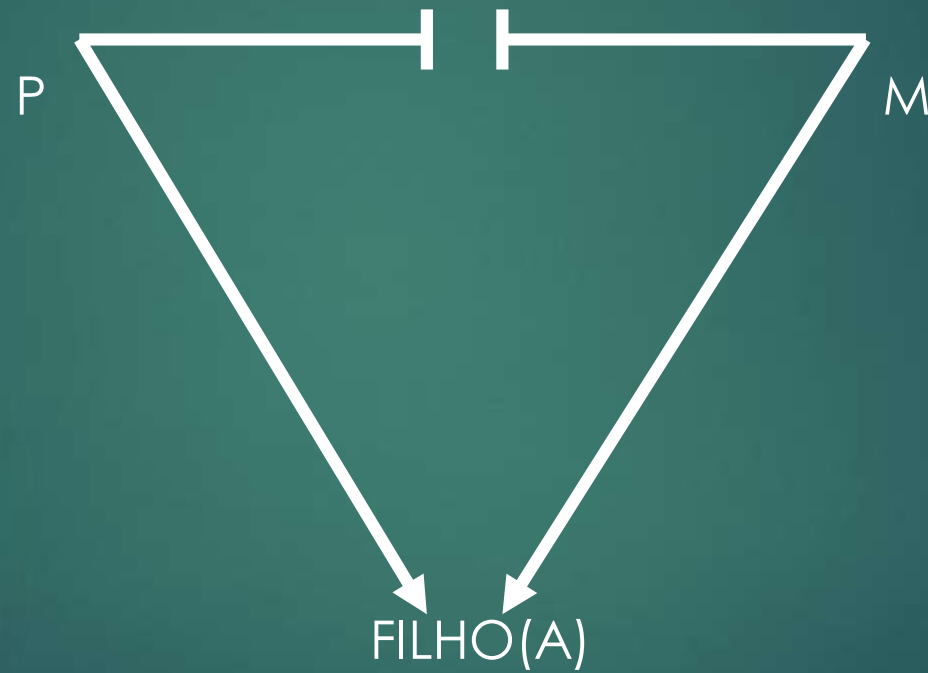
Modelo “normal”



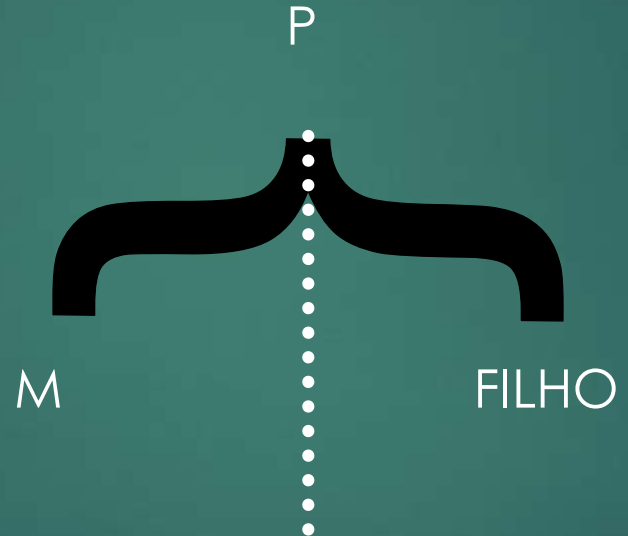
Divórcio e recasamento “normais”



Bode expiatório



Coalizão mãe/criança



Objetivos da Terapia

- Mudar a estrutura familiar
- Terapeuta ativo, altera fronteiras, verifica subsistemas, avalia hierarquias na família, mas o movimento de mudança é da família. Terapeuta provoca a mudança.
- Facilitar o crescimento do sistema e de seus indivíduos, ajuda na resolução dos sintomas e preservar o apoio mútuo das famílias.

Mudanças de Comportamento

- Como mudar?
- Criando padrões alternativos de interação familiar.
- Ativar estruturas adormecidas nas famílias-estrutura funcional

- Aceitar o terapeuta
- Provocar a crise através das intervenções
- Gerar Estresse
- Desequilibrar a homeostase familiar
- Transformação estrutural

- Compreender a visão que a família tem de seus problemas;
- Reestruturar esta formulação do problema, oferecendo uma visão construtiva;
- Usar representações dentro das sessões. Observar e modificar a estrutura da família no contexto imediato da sessão.
- AÇÃO e opções para MUDANÇA

Modelo quatro etapas:

ETAPA 1: Ampliar a queixa apresentada

- Do sintoma ao sistema, sair do PI
- Foco nas competências do PI, encorajá-lo a falar acerca do significado do sintoma
- Reenquadramento
- Explorar as formas de apresentação do sintoma e atentar aos detalhes
- Observar o sintoma sob diferentes perspectivas
- Explorar o contexto

ETAPA 2: Destacar o problema – interações mantenedoras

- Ações de cada um para manter o problema
- “o problema é a forma como a família tenta resolver o problema” (Watzlawick)
- Os membros da família mudarão a si mesmos quando se verem capazes de ajudar a resolver o problema apresentado. Cooperação.

ETAPA 3: Investigar o passado com foco na estrutura

- Como podemos utilizar a exploração do passado de maneira a facilitar a expansão dos padrões de relacionamento do presente?
- “Que experiências em sua infância lhe organizam no sentido de evitar conflitos?”
- “Quem lhe ensinou isso na sua infância?”
- Filhos como audiência das histórias de seus pais, para, na 4ª etapa, se unirem como coparticipantes ativos.

ETAPA 4: Descobrir/cocriar formas alternativas das relações

- Ter clara a redefinição do problema e testar as opções.
- As técnicas servem quando já temos uma visão ampla o suficiente da estrutura familiar
- Dançar com a família

Técnicas

- Mapeamento estrutural
- União e acomodação
- Espontaneidade e coparticipação
- Encenação/dramatização
- Focalização e modificação de interações
- Criação de fronteiras
- Desequilíbrio
- Desafio de suposições improdutivas.
- Intensidade